

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN ESPECIAL-LOGOPEDIA

MATERIAL DOCENTE EN OPCIÓN AL TÍTULO DE MÁSTER EN ATENCIÓN LOGOPÉDICA INTEGRAL

TÍTULO: La Musicoterapia para la corrección de la dislalia funcional en niños de sexto año

Autora: Lic. Gianni Beralia Milanés Duvergel

Tutora: Dr. C. Irelis Escalona Vázquez. P.T

2023

AGRADECIMIENTOS

Lo más hermoso que tiene escribir las líneas que conforman esta página es recordar que una investigación no está conformada solo por quien la materializa, sino por todos los que de una forma u otra brindan apoyo, amor, confianza y aliento, para ellos mil gracias.

- A mi madre por su apoyo y preocupación
- A mi tía Mercedes por toda la sabiduría que ha aportado a esta investigación.
- A todos mis profesores que han sido intachables y supieron ganarse mi respeto y admiración; Por sus consejos y clases tan interesantes.
- Al Dr.C José Joaquín Pérez Peralta por su entrega, por compartirnos su experiencia y por su paciencia.
- A todo el grupo de Maestría que hasta hoy hemos sido tan unidos brindándonos ese apoyo en todo tiempo.
- A mi familia por ser apoyo e impulso para esta caminada.
- Y a ti, por el simple hecho de leer mi trabajo tú también formas parte de mi vida.

Quizás faltaron nombres en esta pequeña lista, pero no quepa la menor duda que agradezco a todos los que siempre estuvieron para mí y a los que no también porque gracias a las adversidades he sabido crecerme.

DEDICATORIA

A mi amado Dios él único que me ha dado la fuerza y la sabiduría para completar esta travesía y poder demostrarme a mí misma que sí se puede y a todos los que me apoyaron desde el inicio hasta el último día.

SÍNTESIS

El presente trabajo está dirigido a analizar el papel de la musicoterapia para la corrección de la Dislalia Funcional en niños y niñas del sexto año de vida en el proceso educativo del círculo infantil Los Pinos Nuevos, y recomendar un sistema de ejercicios musicales que promuevan el desarrollo del lenguaje, al reconocer por los infantes cualidades de los sonidos y familiarizarse con los instrumentos musicales, adicionar canciones infantiles en sus distintos géneros y así despertar en ellos la habilidad para apreciar la música. Para realizar la investigación se aplicaron métodos del nivel teórico y empírico, análisis y síntesis, inductivo y deductivo, entre los métodos de nivel empírico tenemos la observación y entrevistas, los cuales permitieron corroborar las limitaciones que persistían en el proceso educativo y proponer la vía de solución logrando la aplicación de estos ejercicios musicales por la logopeda, maestras de preescolar y especialista de música. La musicoterapia facilita y promueve la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas en los niños y niñas del 6to año de vida, con dislalia funcional.

Palabras claves: corrección, dislalia funcional, lenguaje, musicoterapia, niños, música, logopeda.

SYNTHESIS

The present work is aimed at analyzing the role of music therapy for the correction of Functional Dyslalia in boys and girls of the sixth year of life in the educational process of the Los Pinos Nuevos day care center, and to recommend a system of musical exercises that promote the development of language, by recognizing the qualities of sounds for infants and becoming familiar with musical instruments, adding children's songs in their different genres and thus awakening in them the ability to appreciate music. To carry out the research, theoretical and empirical methods were applied, analysis and synthesis, inductive and deductive, among the empirical level methods we have observation and interviews, which allowed us to corroborate the limitations that persisted in the educational process and propose the way of solution achieving the application of these musical exercises by the speech therapist, preschool teachers and music specialist. Music therapy facilitates and promotes communication, relationships, learning, movement, expression, organization and other relevant therapeutic objectives, in order to satisfy the physical, emotional, mental, social and cognitive needs of 6th year boys and girls. of life, with functional dyslalia.

Keywords: correction, functional dyslalia, language, music therapy, children, music, speech therapist.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

DESARROLLO 9

Diagnóstico del estado actual del desarrollo del lenguaje en los niños del 6to año de vida para erradicar la dislalia funcional. 9

Resultados de la observación a actividades programadas, encuesta a la logopeda, maestras y a especialista en educación musical. 9

Fundamentos teóricos y metodológicos acerca de la musicoterapia para corregir la dislalia funcional en los niños y niñas del 6to año de vida. 12

La Dislalia. Trastorno del lenguaje 27

Algunas consideraciones acerca de la atención logopédica en el desarrollo del lenguaje en los niños. 31

Propuesta de ejercicios musicales para corregir la dislalia funcional. 33

Propuesta de ejercicios musicales 35

Valoración de los resultados 52

CONCLUSIONES 54

RECOMENDACIONES 55

INTRODUCCIÓN

La música forma parte de la vida en todo el mundo, se usa para celebraciones, feriados, experiencias religiosas, y para entretenimiento, inspira calma, excita y une a personas de todas las edades. Sin lugar a dudas, es un elemento primordial para lograr el equilibrio afectivo, intelectual, sensorial y motriz que persigue la educación en el nivel pre-escolar y escolar. La música afecta y trabaja en todos los niveles de desarrollo; socio afectivo, cognitivo, motor, y el lenguaje.

Es además una fuente generadora de emociones positivas que propician un estado anímico favorable para la asimilación de saberes, normas de convivencia y formas de relacionarse. Los estados emocionales repercuten en el sistema nervioso central; la música adecuada estimula el desarrollo y perfeccionamiento de los órganos sensoriales, por excelencia el oído; es un buen medio para potenciar las características positivas de la personalidad de cada uno, fomenta la extroversión, el compañerismo y la sensibilidad musical.

La enseñanza de la música está normada a partir de diferentes documentos como el Programa de Educación Preescolar, Segunda parte, Cuarto ciclo, que trata sobre la Educación Musical y Expresión Corporal (Colectivo de autores, 2014) en el cual se realiza un análisis donde explican que a modo de ejercicio el niño de esta edad va a ser capaz de repetir frases musicalizadas y contestar saludos con una melodía dada por la educadora.

Referente al tema de investigación, en el libro "Educación Musical y Expresión Corporal", la Dr.C. Paula Sánchez Ortega y MSc. Xiomara Morales Hernández (2012) expresan que, el lenguaje en la música como comunicación humana está presente desde los primeros días del nacimiento, cuando la madre le canta al bebé canciones de cuna y realiza juegos rítmicos musicales con él, trasmite conocimientos, emociones y sentimientos.

La Educación Musical transmite un caudal de saberes a los niños, que son procesados de forma amena, divertida, despierta emociones y sentimientos. Esta influye notablemente en el cuidado de la voz, fortalece las cuerdas vocales, aumentando la capacidad funcional, entrena la respiración y perfecciona la articulación y pronunciación de los sonidos del idioma, favoreciendo también el oído fonemático. En las actividades de musicoterapia se desarrolla el analizador auditivo a través de la discriminación de diferentes sonidos teniendo en cuenta sus cualidades.

La música trabaja en todos los niveles de desarrollo; socio afectivo, cognitivo, motor, y lenguaje; puede lograr que los pequeños se acerquen a las personas, el niño que tiene contacto con la música aprende a convivir en armonía con otros niños, estableciendo una amplia comunicación.

Es válido señalar, que la música tiene poder para calmar las tensiones, lograr equilibrio y controlar el exceso de energía en los niños, aportando también en el desarrollo cerebral, esto la convierte en una herramienta que

debería ser utilizada constantemente por los maestros de preescolar, a fin de garantizar el éxito presente y futuro de los niños.

La música infantil es un repertorio autónomo por excelencia, de gran valor artístico, expresa sentimientos y emociones que se cultivan en el maravilloso de los niños. A través del verso y la canción, los niños toman contacto con su entorno, intentan conocerlo, apropiarse de él y dominarlo, tienen la capacidad de inventar, imaginar, creando una música en la que se refleja su imaginación.

Todas las culturas tienen repertorios de música infantil, lenguaje simple que crean y cultivan los niños. Estas canciones musicales literarias están determinadas por las posibilidades interpretativas de los niños y están íntimamente ligadas al nivel de desarrollo psicofísico.

La musicoterapia, ha sido objeto de investigaciones en trabajo de diplomas y experiencias pedagógicas, las cuales se toman como antecedentes para el presente estudio como las Tesis de Maestría de Deysi Delgado (2016), Nayla Rodríguez (2017), Himilce Cabrera Toledano (2008), Yoannia Suárez (2021), Alberto Andrés Trejos Tamayo (2018) y Maritza Catalina Miranda Ramírez (2019), investigaciones relacionados con el desarrollo del lenguaje, desarrollo físico, desarrollo del oído, la voz y expresión corporal. Son pocos los trabajos encaminados a la musicoterapia directamente.

En España, los doctores en ciencias Andrea Giráldez y Andrés Palacios (2020), investigaron sobre la intervención de la musicoterapia en casos de niños con y sin diagnóstico de trastorno por déficit de atención/ hiperactividad (TDAH), como una forma de contribuir a la mejora de los procesos de inclusión educativa y social de niños con este diagnóstico y al desarrollo de la capacidad de gestión emocional tanto suya como de los niños sin este diagnóstico.

Las investigaciones precedentes a este estudio y la experiencia profesional de esta autora han permitido precisar como **diagnóstico fáctico**:

- Los niños no logran enfatizar algunos sonidos del habla
- Omiten y sustituyen sonidos. (zapato por pato) y (codo por todo)
- En el análisis fónico no logran articular correctamente los fonemas.
- Tienen baja autoestima e inseguridad.

Partiendo de las reflexiones planteadas anteriormente se determina como **problema científico:** ¿Cómo corregir la dislalia funcional en los niños y niñas de 6to año de vida del Círculo Infantil Los Pinos Nuevos mediante la musicoterapia?

Objeto de investigación: El proceso de atención logopédica en el 6to año de vida del Círculo Infantil "Los Pinos Nuevos". Teniendo como **Tema**: La musicoterapia para la corrección de la dislalia funcional en niños de 6to año. **Campo de acción**: Corrección de la dislalia funcional. **Objetivo**: Elaborar

un sistema de ejercicios musicales para corregir la dislalia funcional en los niños y niñas de 6to año de vida del círculo infantil Los Pinos Nuevos.

Partiendo del análisis anterior se establece la siguiente idea a defender**:** La implementación de un sistema de ejercicios musicales en las actividades de Educación musical y procesos que se desarrollan en el círculo infantil "Los Pinos Nuevos" favorece una mejor atención logopédica para la corrección de la dislalia funcional en niños y niñas de sexto año de vida.

Tareas científicas:

1. Diagnosticar el estado actual del desarrollo del lenguaje en los niños del 6to año de vida.
2. Determinar los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan las potencialidades que tiene la musicoterapia para corregir la dislalia funcional en niños y niñas del 6to año de vida.
3. Elaborar ejercicios musicales que permitan corregir la dislalia funcional en los niños de 6to año de vida.
4. Valorar la efectividad de los ejercicios musicales para corregir la dislalia funcional en los niños del 6to año de vida.

Métodos del nivel teórico:

Análisis y síntesis: Con el objetivo de consultar bibliografías actualizadas relacionadas con el desarrollo del lenguaje, la musicoterapia, el tratamiento

a la dislalia funcional y analizar los datos y confeccionar la fundamentación teórica, el aporte de la musicoterapia.

Inducción y deducción: Con el propósito de llegar a conclusiones y generalizar de forma lógica los datos empíricos.

Modelación: Con el objetivo de modelar los ejercicios propuestos.

Método Empírico

Entrevista a la logopeda, maestras y especialista de Educación musical con el objetivo de comprobar los métodos empleados para corregir en los niños/as la dislalia funcional.

Experimento: para diagnosticar el estado actual del desarrollo del lenguaje de los niños con dislalia funcional del 6to año de vida.

Observación: Con el objetivo de observar en las actividades programadas cómo se le da tratamiento metodológico al desarrollo del lenguaje en el área de Lengua Materna en los niños del sexto año de vida.

Método Estadístico Matemático.

Técnica del porciento: con el objetivo de tabular los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y final.

Significación práctica: La investigación va a aportar a la institución preescolar una vía mediante la cual, corregir la dislalia funcional a través de actividades que se pueden realizar a través de la Dimensión Estética en el

área de Educación Musical y en cada proceso básico donde se dará tratamiento al lenguaje de los niños y niñas ya sea con dislalia funcional u otras alteraciones del lenguaje y así el niño o niña pueda enfatizar los sonidos del habla y realizar el análisis de las palabras sin mayores dificultades.

Novedad Científica: lo novedoso de la investigación es precisamente incorporar ejercicios musicales con un enfoque musicoterapeuta, en todos los procesos básicos del círculo infantil para un desarrollo integral del lenguaje en los niños y niñas de 6to año de vida, ya que gracias a su potencialidad se han visto resultados satisfactorios.

Población y muestra: Nos enfocamos en el salón de 6to año de vida que cuenta con una población de 25 niños y niñas, de los cuales se escogen intencionalmente una muestra de 7 niños por ser los que presentan Dislalia Funcional, objeto de interés por parte de la investigadora.

Actualidad: La Investigación está integrada al proyecto Inclusión social y educativa de personas con discapacidad, se corresponde también con las líneas de investigación de la Maestría en Atención Logopédica Integral.

Línea de investigación: la atención logopédica integral para la inclusión educativa y social de niños (as), adolescentes y adultos con alteraciones en la comunicación y el lenguaje.

Este tema es **importante**, porque a través del tratamiento con musicoterapia los niños y niñas pueden experimentar y transmitir emociones y sentimientos, desarrolla habilidades para escuchar, diferenciar e identificar sonidos de su entorno y luego memorizarlos para una mejor expresión oral, acostumbra al niño al disfrute de la buena música y lo hace partícipe del hecho sonoro; contribuye a desarrollar habilidades lingüísticas porque favorece el desarrollo del oído fonemático donde el niño puede lograr discriminar los sonidos de las palabras y aprender a conversar aprendiendo a escuchar a sus compañeros, les permitirá analizar y enfatizar cada sonido mediante los ejercicios, lo que también pueden realizar las familias en el hogar, posibilitando además realizar el análisis fónico de las palabras sin dificultad.

El presente estudio consta de introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y un cuerpo de anexos que sustentan la investigación.

DESARROLLO

Diagnóstico del estado actual del desarrollo del lenguaje en los niños del 6to año de vida para erradicar la dislalia funcional.

La investigación se realiza en el círculo infantil "Los Pinos Nuevos" del Consejo popular "Mariana Grajales" ubicado en el municipio de Santiago de Cuba. Esta institución educativa cuenta con un universo constituido por 204 niños y niñas, escogiéndose como población a 25 de ellos (as) que pertenecen al sexto año de vida, de los cuales se escogen intencionalmente a 7 por ser los que presentan Dislalia Funcional, objeto de interés por parte de la investigadora.

Para desarrollar el estudio diagnóstico inicial se toman en cuenta los indicadores siguientes: …

- Creación de las condiciones para las actividades que se planifican dirigidas al desarrollo del lenguaje
- Orientación de los objetivos de las actividades
- Desarrollo del contenido propuesto
- Efectividad de las actividades de música para el desarrollo del leguaje

Resultados de la observación a actividades programadas, encuesta a la logopeda, maestras y a especialista en educación musical.

Se corroboran las insuficiencias que presentaron los niños y niñas del sexto año de vida en el desarrollo del lenguaje, las cuales se obtuvieron a través

del diagnóstico inicial para el que se realizó una observación a las actividades programadas.

Se constató que, de 8 actividades observadas, en la creación de condiciones existían dificultades en cuanto a la planificación y organización del local, de la cantidad de niños escogidos para la actividad y el vestuario de los niños y seño, de 8 actividades solo 3 tenían una correcta planificación y organización para darle cumplimiento a los objetivos propuestos.

Las áreas de desarrollo del proceso educativo en el sexto año de vida, especialmente la dimensión comunicación y la dimensión estética, no siempre tienen en cuenta la atención logopédica a niños y niñas con dislalia inicial, desde el asesoramiento de la logopeda.

Con respecto a la dimensión comunicación, considera diversas acciones para el desarrollo de la expresión oral, pero en la dimensión estética no siempre se utiliza el canto y la rítmica musical para potenciar las habilidades para el desarrollo de la expresión oral y el canto.

Se realizó la entrevista a una logopeda, dos maestras de preescolar y a una especialista de Educación Musical. La educadora musical es la única que interactúa musicalmente con estos niños dando tratamiento a los que presentan dislalia funcional porque las otras especialistas utilizan otros métodos y medios para trabajar la atención logopédica.

Conclusiones Diagnósticas:

- Los logopedas no se auxilian de las potencialidades de la Educación Musical para la corrección a la dislalia funcional en niños y niñas preescolares.
- El programa de la Dimensión estética, no siempre brinda un tratamiento suficientemente profundo e integrado para el desarrollo de las habilidades de expresión oral fluida de niños y niñas de aulas preescolares.
- Aún resulta insuficiente la incorporación de nuevas canciones con potencialidades para la corrección de la dislalia funcional en los niños (as) preescolares.
- Resulta insuficiente la integración entre el trabajo del logopeda y el especialista de Educación Musical para la corrección de la dislalia funcional en los niños (as) preescolares.

Fundamentos teóricos y metodológicos acerca de la musicoterapia para corregir la dislalia funcional en los niños y niñas del 6to año de vida.

Musicoterapia y lenguaje.

La enciclopedia en línea Wikipedia define a la musicoterapia de la siguiente forma:

> La musicoterapia es el manejo de la música y sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) realizada por un musicoterapeuta calificado, con un paciente individual o un grupo. Es un proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. (p. 1)

La musicoterapia, según Palacios Sanz (2001), es una disciplina científica que utiliza la música y elementos sonoros como el ritmo, melodía, armonía, el silencio, con objetivos terapéuticos. Está enfocada en la salud y el bienestar de las personas, se trabaja mucho la atención, la concentración, la motricidad fina, es un proceso abierto enfocado en la salud y bienestar.

Al respecto Rolando Omar Benenzon (1985), expone que la musicoterapia es la técnica de comunicación que utiliza la música y los sonidos para producir fenómenos regresivos y abrir canales de comunicación a través de

los cuales se puede comenzar el proceso de recuperación y rehabilitación del paciente.

Muñoz del Mazo E y de la Torre Rísquez A (2016) señalan:

> En 1996, la Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT) publicó la siguiente definición: "La musicoterapia es el uso de la música o los elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un musicoterapeuta cualificado con un cliente o grupo de clientes, en un proceso diseñado para promover la comunicación, las relaciones personales, el aprendizaje, la movilización, expresión, organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para producir cambios a nivel físico, emocional, mental, social y cognitivo. La musicoterapia se utiliza para desarrollar potenciales y/o recuperar funciones que permitan al individuo adquirir una mejor integración inter e intra personal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida mediante la prevención, rehabilitación o tratamiento". (p. 217)

Agregan que existen varios tipos de musicoterapia, una de ellas es la musicoterapia clínica**,** en este caso, destinada para trabajar con niños y niñas con discapacidad, con dificultades de comunicación y lenguaje, problemas en el desarrollo general, patologías de carácter físico, cognitivo y emocional.

Por su parte Álvarez Navarro, H. (2019) señala la influencia de la musicoterapia en los niños a partir de la estimulación musical y plantea que "Con esta estimulación se activan partes del cerebro, estimulando la inteligencia desde todas las áreas de conocimiento, como la adquisición de lenguaje, el control motor, la comprensión de conceptos matemáticos, la creatividad" (p. 35)

La Musicoterapia actúa de manera holística sobre el cuerpo en diferentes niveles y activando diversas funciones que son necesarias para el normal desenvolvimiento del individuo, así puede verse las diferentes influencias que ejerce esta técnica sobre el individuo.

Nivel	Función
Fisiológico	Dar respuesta fisiológica en el organismo en función del estímulo musical, su percepción y experiencia.
Emocional	Facilitar la comunicación de forma no verbal
Conocimiento	Desarrollar habilidades preacadémicas y académicas
Social	Favorecer las habilidades sociales
Espiritual	Crear una atmósfera para meditar o reflexionar

La acción se la musicoterapia es señalada por Rugguero (2011) cuando señala sus diferentes efectos sobre el organismo, de manera que provoca:

1. Efectos fisiológicos: desarrolla el sentido del oído, enseña a conocer y organizar el mundo de los sonidos.
2. Efectos psicológicos: facilita los fenómenos de catarsis y sublimación. La música estimulante aumenta la energía corporal y estimula las emociones. La música sedante produce sedación física y una respuesta intelectual contemplativa.
3. Efectos intelectuales: Ayuda a desarrollar la capacidad de atención sostenida, por su inmediatez, persistencia y constante variedad. Facilita volver a la realidad, estimula la imaginación, la capacidad creadora y la reflexión.

En confluencia con estos tres efectos principales, la música posibilita una experiencia de relación con los demás, ofreciendo medios para expresarse de manera socialmente aceptable, orientando la conducta hacia los otros, fomentando la comunicación verbal y no-verbal. De lo expuesto se infiere entonces que, la musicoterapia contribuye al desarrollo y educación de la comunicación y con ella el lenguaje.

Para Benenzon, la musicoterapia preventiva, se trabaja con niños de 0 a 24 meses intentando ofrecerles un espacio creativo y estimulante para el desarrollo sano y feliz, se aplica además con jóvenes y adultos de la tercera edad donde se busca mantener la actividad cerebral y procesos circulantes activos, tales como la memoria, el procesamiento de la información, la percepción, etc… y se utiliza mayormente el piano.

Al decir del autor, esta técnica se emplea también con mujeres embarazadas ofreciéndoles un espacio donde se cubren sus necesidades físicas, sociales, emocionales, cognitivas tanto para ella como para el bebé y su pareja. Proporciona herramientas para llevar un embarazo pleno y un parto exitoso.

La Federación Mundial de musicoterapia (FEAMT) (1996) se refiere al uso de la música y/o sus elementos (sonido, ritmo, melodía, armonía) realizado por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo, en un proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas.

Para la FEAMT, la musicoterapia tiene como fin desarrollar potencialidades y/o restaurar las funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración intra y/o interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento.

Para Bruscia (1989) el proceso musicoterapéutico en la terapia es cambio gradual hacia un estado deseado; para el terapeuta, es una secuencia sistemática de intervenciones dirigidas a lograr cambios específicos en el cliente.

Según plantea Bruscia (2007), la musicoterapia es un proceso sistematizado y metodológico que se realiza en tres etapas, Diagnóstico, tratamiento y

evaluación, las cuales pueden llevarse a cabo de forma separada o simultánea:

- La primera instancia de **diagnóstico**, dependiendo los objetivos del terapeuta, sirve, como el nombre de la etapa sostiene, para realizar un diagnóstico, una interpretación clínica, describir, determinar un tratamiento específico para el paciente o evaluar para posteriormente re-evaluar y registrar diferencias.
- La segunda etapa del proceso terapéutico es la de **tratamiento**, en donde se direcciona el trabajo mediante estrategias para alcanzar las metas propuestas sobre la base de las necesidades, problemas y recursos del paciente revelados durante la etapa diagnóstica. Cada sesión involucra al cliente en algún tipo de experiencia musical. Bruscia clasifica las experiencias en cuatro tipos:

➢ Improvisación. El cliente crea su propia música cantando o tocando un instrumento.

➢ Re-creación. El cliente canta una canción, o toca una pieza musical ya compuesta, de memoria o leyendo música.

➢ Composición. Se compone sobre la base de estructuras musicales.

➢ Escucha. De música grabada o en vivo.

- En la tercera instancia de evaluación se determina si las condiciones del paciente se han modificado mediante el proceso musicoterapéutico.

La musicoterapia se desarrolla profesionalmente tanto en el ámbito público como privado, en abordajes grupales como individuales, en prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. Las metodologías de trabajo varían de acuerdo a la población y a las escuelas y constructos teóricos que fundamenten el quehacer del musicoterapeuta.

Los componentes que se trabajan en la primera Infancia son: desarrollo del oído musical, desarrollo de la voz, desarrollo rítmico y expresión corporal. Estos componentes tienen objetivos y contenidos que se desarrollan de forma interrelacionada en las actividades que se realizan con los niños en ambas modalidades de atención, y en las diferentes formas de organizar el proceso educativo.

Zoppi (2021), sostiene que, la Musicoterapia consiste en usar las respuestas y conexiones de una persona con la música para estimular cambios positivos en el estado de ánimo y el bienestar general. La terapia musical puede incluir crear música con instrumentos de todo tipo, cantar, moverse con la música o simplemente escucharla.

Plantea Lucía Rello (2014), que la musicoterapia ayuda al desarrollo temprano de las redes del proceso auditivo en el cerebro. Estas redes son

utilizadas para descifrar y encontrar significado, sentido a los sonidos y al lenguaje oral, lo cual ayuda a las personas con necesidades específicas, con dislexia, dislalias o trastornos específicos del lenguaje entre otros. Las canciones introducen nuevo vocabulario y esto produce la activación de la memoria de trabajo en el área del aprendizaje del vocabulario y de la conciencia fonológica.

Según Cintia Tejedor (2016), la musicoterapia es un medio de rehabilitación que incide tanto desde el punto de vista fisiológico, como puede ser la ejercitación de la voz, movimiento, etcétera. Desde la perspectiva emocional e intelectual proporciona un desarrollo afectivo y cognitivo. El niño con problemas del lenguaje puede hallar más simple y atractivo la ejecución de una melodía, que la expresión simple de una palabra o de una frase.

Para la autora, la musicoterapia permite que los pequeños desarrollen habilidades de socialización no solo con los de su edad, sino también con las personas adultas, refiere que el niño que tiene contacto con la música aprende a convivir en armonía con otros niños, estableciendo una amplia comunicación; Para ellos, cantar o realizar juegos de expresión musical y rítmica, representa un medio de expresión de gran valor emocional y placentero. Las repeticiones verbales y algunos de los ejercicios propuestos en logopedia, les cansa o le aburren.

La musicoterapia tiene un papel muy importante en la tarea de la adquisición del lenguaje con niños y niñas con trastornos o patologías ya que permite

la comunicación no verbal necesaria en la prevención de otro tipo de retrasos en el aprendizaje y la interacción social.

Por su parte Medina (2016), sostiene que la falta de comunicación puede propiciar una conducta inadaptada en aquellos sujetos que la padecen y es necesario abordar el problema cuanto antes para ofrecer al niño un medio de comunicación y expresión suficiente y adecuada a su edad y características.

Desde el punto de vista **Psicológico** la musicoterapia desarrolla funciones cerebrales tales como la memoria, la orientación, el equilibro, la movilidad y la coordinación. También conecta directamente con las emociones, las provoca, las evoca y al mismo tiempo ayuda a expresarlas. Por este motivo, constituye una herramienta útil para la Psicología.

Según, Bruscia (1995) se usa como herramienta terapéutica, puede ser muy útil para analizar relaciones significativas, expresar aspectos emocionales ligados a vivencias concretas, explorar aspectos propios del yo, hablar de las identificaciones y los aspectos que conforman la personalidad del sujeto, explorar la historia de vida, elaborar experiencias traumáticas. Elaborar duelos, calmar, bajar el nivel de activación o angustia en el paciente cuando ésta resulta insoportable y no operativa para el trabajo terapéutico.

Agrega Bruscia, que a través de la musicoterapia se pueden explorar aspectos inconscientes, comunicar aspectos íntimos, relatar analogías,

encontrar aspectos relativos a las incoherencias del yo o contradicciones, expresar musicalmente pensamientos, sensaciones o vivencias, propiciar el debate de aspectos relativos a la personalidad, facilitar el hecho de poner palabras, explorar vivencias significativas, explorar aspectos propios del yo, comprender aspectos emocionales, gestionar y canalizar aspectos emocionales, simbolizar aspectos vitales o psíquicos.

Desde el punto de vista **Pedagógico**, la musicoterapia contribuye a crear un ambiente agradable en el aula, cuando se imparte cualquier asignatura o se desarrolla alguna actividad práctica. En este caso, el alumno la escucha de manera pasiva, algo inconsciente, pero repercute de forma directa en su bienestar, en su modo de estar y actuar en el entorno educativo.

Como herramienta directa de trabajo, bien para aprender música o bien para potenciar habilidades motoras y comunicativas. En este caso, el alumno participa activamente al crearla con instrumentos, moverse a su ritmo o realizar una escucha atenta que despierta sus emociones de manera consciente.

Para (Thayer Gaston, 1982) y (Rolando O. Benenzon, 1992), coinciden en que la musicoterapia tiene las siguientes propiedades:

- El establecimiento o restablecimiento de las relaciones interpersonales.
- El logro de la autoestima mediante la autorrealización.

- El empleo del ritmo para dotar de energía y organizar.
- La identificación sonora personal, grupal y social que motiva y estimula.
- El desencadenamiento de un proceso indirecto de cambio, al actuar como objeto intermediario que no despierta miedo, timidez, desconfianza o alarma.

Desde el punto de vista **Fisiológico** según Medina (2016), la musicoterapia es un medio de rehabilitación puramente fisiológico, como puede ser la ejercitación de la voz, movimiento, desde la perspectiva emocional e intelectual que proporciona un desarrollo afectivo y cognitivo, la dinámica planteada de modelos melódicos y rítmicos, influye en el desarrollo del habla intencional.

El autor señala que el niño con problemas de lenguaje puede hallar más simple y atractivo la ejecución de una melodía, que la expresión simple de una palabra o de una frase. Para él, cantar o realizar ejercicios de expresión musical y rítmica, representa un medio de expresión de gran valor emocional y placentero; las repeticiones verbales y algunos de los ejercicios propuestos en logopedia, les cansa o le aburren.

Desde el punto de vista **didáctico** la musicoterapia es utilizada cuando una persona necesita desarrollar sus sentidos como son: auditivo, intelectual, sensorial, del habla y primordialmente el sentido motor del niño, aunque puede desempeñarse en cualquier edad; proporciona una serie de beneficios

para nuestros niños y adolescentes, generando una variedad de sentimientos, en la cual les enseñan a tener amor propio y reconocer su personalidad, estos beneficios son los siguientes:

- Permite que los niños desarrollen su oído musical
- Favorece en la expresión artística
- Ayuda a participar, organizar y sincronizar sus movimientos
- Al cantar con algún instrumento ayuda a la estimulación del tacto
- Desarrolla la imaginación y la capacidad creativa
- Refuerza la memoria
- Ayuda en el tratamiento de problemas del lenguaje
- Ayuda a exteriorizar las emociones
- Facilita las relaciones sociales y es un referente cultural

Actualmente, el docente crea una educación pedagógica, centrándose en el área de lenguaje y literatura, fijándose especialmente en dictados musicales, estos podrían tener buenos resultados como: su ortografía, escritura, mejoramiento de la memoria y la parte auditiva del niño, el docente guiará y evaluará los resultados obtenidos.

Al analizar cada uno de estos conceptos la autora de esta investigación considera que, la musicoterapia no es más que la terapia que se aplica a través de la música a distintas personas, con disímiles fines.

Para los especialistas que aplican la musicoterapia en su trabajo, un elemento a tener en cuenta es la relación de esta técnica con el lenguaje como forma para obtener una comunicación efectiva, la cual en ocasiones se utiliza para tratar trastornos como, la dislalia funcional, objeto de interés por parte de la investigadora.

Lafarga (2000), asegura que la música y el lenguaje pueden considerarse como dos códigos diferentes de comunicación (los cuales se entrelazan cuando cantamos para constituir un código común), como dos sistemas formales elaborados capaces de transmitir una información y unos valores culturales, sociales, emocionales e intelectuales.

Plantea además Yoadnia, Suárez (2021), que la Educación musical, establece un vínculo estrecho con los métodos y procedimientos para el tratamiento de los trastornos del lenguaje y el propiciar un ambiente emocional positivo en el proceso de atención logopédica integral por lo que los componentes de la Educación musical, constituyen un instrumento de gran utilidad en función de la prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación.

Considera la autora que la Educación Musical interactúa con el canto, la danza, los ejercicios rítmicos, la improvisación y creatividad para el disfrute de los niños, el desarrollo del pensamiento, las sensaciones agradables que estimulen el disfrute y la comunicación oral, esta área de la "dimensión estética" entrena en las capacidades de atención y concentración desde el

trabajo con la respiración como técnica principal para relajarse ante las tensiones.

Autores como (Pascual, 2007; Jiménez Obispo, 2006; Artigas, Rigao y García 2008), opinan que el sujeto con dislalia funcional canta y recita correctamente si lo hace con un mismo nivel rítmico, por cuanto no necesita realizar un programa de selección previa para lograr la disposición armoniosa de pausas en el flujo verbal, tal como ocurre en el proceso de realización del lenguaje normal.

Dada la relación que existe entre música y lenguaje, es válido referir en nuestra investigación que el lenguaje, al decir de Sapir (1995), es un método exclusivamente humano y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada.

Por su parte Piaget (1968) sostiene que este aparece en un momento de transición entre la inteligencia sensorio-motora y la que se va desarrollando en el periodo preoperacional, debido a los aportes y sincronización de la inteligencia sensorio-motora y la función simbólica.

Según La Real Academia de la Lengua Española (2019) lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. La aptitud para

expresarse se manifiesta en la capacidad humana para comunicar pensamientos y sentimientos a través de la palabra.

Para el Diccionario de Psicología (1989), el lenguaje es la capacidad de expresar el pensamiento por medio de sonidos en la producción de los cuales interviene la lengua. Con sus trabajos desde finales de los 50 hasta los años 80, Noam Chomsky (Filadelfia, 1977) reveló cómo la adquisición del lenguaje depende de la facultad innata de la mente humana que permite comprender y generar oraciones basadas en los principios formales de la "gramática universal".

P.G, Richmond (1981), destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de los diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo.

Acerca del lenguaje, Dabbah (1994), considera que como medio de expresión humano, es signo del despertar intelectual del niño, señal de vivacidad, imaginación, sentido de observación y maduración, así como índice de desarrollo de la inteligencia, equilibrio afectivo y expansión del carácter, por lo que su desarrollo normal es de suma importancia.

Desde la visión de Castañeda (1999), el lenguaje tiene una serie de funciones importantes en la vida de los seres humanos, entre las que se encuentran:

- Función comunicativa: la función primaria del lenguaje es la comunicación.
- Función cognoscitiva: es un instrumento poderoso para el aprendizaje y la abstracción.
- Función instrumental: el lenguaje verbal permite satisfacer necesidades inmediatas como hambre, sed, frío, etc.
- Función personal: expresar opiniones, sentimientos, motivaciones, puntos de vista, etc.
- Función informativa: permite obtener información de lo que ocurre a nuestro alrededor y en el mundo en que vivimos.
- Función adaptativa: el lenguaje verbal o habla permite al individuo adaptarse adecuada y competentemente al medio social.
- Función reguladora del comportamiento: como regulador del comportamiento permite al niño, como al adulto, establecer y mantener relaciones sociales.

La Dislalia. Trastorno del lenguaje

Qué es la dislalia

Muchas son las definiciones que existen de dislalia, trastorno que al decir de Monfort Marc (1993), es el trastorno funcional permanente, incluso en repetición de fonemas aislados, de la emisión de un fonema sin que exista causa sensorial ni motriz a dicho fenómeno, en un sujeto de 4 años.

Para Pascual, G. P. (1998), son alteraciones en la articulación de los fonemas, que ocasionan una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas; ésta puede afectar cualquier consonante o vocal, se trata de un sonido o fonema que no se produce en forma correcta, a pesar de que sea percibido y sea diferenciado normalmente de otros sonidos.

O sea, que el fonema afectado no aparece en el inventario fonético del niño, ni en el lenguaje espontáneo, ni en el lenguaje repetido, ni tampoco es capaz de realizarlo en forma aislada. La incorrección que produce es estable; es decir, el fonema se realiza incorrectamente y siempre en la misma forma.

Hay que decir también que el sistema fonológico del niño está bien construido, que dispone de una representación mental de los fonemas y puede organizar sus ideas y escribirlas; una vez establecido el marco conceptual de las dislalias es necesario establecer la clasificación de las mismas.

Teniendo en cuenta la visión de los diferentes autores, la presente investigación asume que la dislalia se clasifica en cuatro tipos: evolutiva, audiógena, orgánica y funcional.

Al respecto, Sánchez, Escobedo Pedro (1977), denomina *dislalia evolutiva* a la fase del desarrollo del lenguaje infantil en la que el niño o la niña no es capaz de repetir por imitación las palabras que escuchan, y repiten las

palabras en forma incorrecta, desde el punto de vista fonético. Aunque estas dificultades en la articulación de los fonemas no suelen perdurar en el tiempo, más allá de los cinco o seis años, no es sostenible la creencia de una desaparición espontánea generalizable a todos los casos.

Para Timoteo (2010), en la *dislalia audiógena*, el factor fundamental para logar la articulación del lenguaje es la audición, pues el niño o la niña que no oyen bien cometen errores en la pronunciación. Sin embargo, la intensidad de la pérdida auditiva puede ser de diversos grados, por tal motivo es indispensable la atención de un otorrinolaringólogo para diagnosticar el problema.

De acuerdo a lo planteado por la autora, se considera que el niño o la niña que no oyen bien, no articulan correctamente; confunden los fonemas que ofrecen alguna semejanza, porque no pueden discriminar en forma auditiva.

Considera además Timoteo (2010), que se denomina *dislalia orgánica*, a los trastornos de la articulación que están originados por deficiencias orgánicas, generadas por malformaciones o lesiones en los órganos de habla ocasionada por accidentes.

La *dislalia funcional,* agrega Timoteo*,* es el trastorno de la articulación más frecuente en niños, consiste en la sustitución, distorsión, adición u omisión de las consonantes como: /l/, /r/, /k/, /s/, /t/. Algunas de las causas que generan este trastorno pueden ser: dificultades para respirar;

discriminación auditiva; falta de interés por pronunciar bien. Por tal motivo la dislalia funcional es base de interés de esta investigación.

Para González Reinoso, Jeaneth (2013), es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje, por una función anómala de los órganos periféricos en la que se da las anomalías anteriormente descritas al tratar del concepto general de la dislalia, sin que existan trastornos o modificaciones orgánicas en el sujeto, si no tan solo una incapacidad funcional.

En su análisis refieren que la dislalia funcional puede darse en cualquier fonema, pero lo más frecuente es la sustitución, omisión o deformación de la /r/- /k/ -/l/ -/s/ -/z/ y /ch/. Existen estudios que demuestran la prevalencia de la dislalia funcional, como el trastorno del habla de mayor frecuencia. (Taboada; Torres; Cazares y Orozco 2011), refieren que el trastorno del habla frecuente entre los escolares lo constituyen las alteraciones en la pronunciación conocidas como dislalias.

Es entonces oportuno plantear que, al no ejecutar un tratamiento fonoaudiológico a temprana edad repercutirá en el proceso comunicativo, las interacciones diarias y ocasionalmente en la personalidad y la conducta del estudiante, pues quien padece y es consciente de la alteración, sentirá la necesidad de inhibir palabras que reflejen su dificultad o bajar la intensidad de su voz e incluso llegar a comunicarse con menor frecuencia.

Para Moreno y Mateos (2005), los niños con dislalia funcional tienen dificultades para relacionarse con los demás, se muestran inhibidos, son más propensos a perder el control emocional y manifiestan una ansiedad, tensión e inseguridad. En la experiencia como docente, la autora de la presente investigación, considera que la dislalia funcional puede confundirse con otro tipo de problemas o actitudes del niño/a como la timidez, miedo al hablar, indiferencia al trabajo.

Una situación vivida a lo largo de esta pesquisa, fue que el niño/a proviene de una familia que considera que el niño/a debe permanecer callado cuando un adulto se dirige a él, no debe opinar o contradecir al adulto, por tales motivos se generan temores al hablar y en consecuencia no le es fácil expresar lo que piensa o siente, para el niño el adulto siempre tiene la razón, sin embargo su expresión oral con otros niños de su edad es normal.

Algunas consideraciones acerca de la atención logopédica en el desarrollo del lenguaje en los niños.

Resulta imprescindible una adecuada atención al lenguaje en escolares que presentan trastornos como la dislalia funcional, para prevenir, corregir y/o compensar dicho trastorno que afectan severamente la función comunicativa del lenguaje.

Según Pérez, E. (2002), la atención logopédica es un proceso de alternativas pedagógicas que se insertan en la dirección del aprendizaje, al estructurar los niveles de prevención para las personas con necesidades educativas en

la comunicación verbal. Tiene como rasgos principales su carácter procesal, sistémico, de ofrecer opciones pedagógicas, ser flexible, variable y diferenciado porque depende de cada persona y contexto y es susceptible de generalización.

La autora destaca que no es un servicio paralelo al proceso pedagógico, no puede sacarse al alumno del aula para —como es práctica actual— recibir esta ayuda. Se concibe como un proceso natural que transcurre en diferentes momentos (actividades docentes, extra-docentes y extraescolares y el contexto familiar y comunitario) e involucra diversas personas (educador, logopeda, familia, vecinos, médicos, psicólogo y otros especialistas) y espacios (aula común y logopédica, áreas escolares, el hogar, el área de salud y la comunidad).

Para Morales Sarabia M. E. (2004), el proceso de atención logopédica está dirigido a la prevención, la estimulación y el desarrollo del lenguaje, la corrección la compensación de los trastornos del lenguaje y de la comunicación.

La autora de esta investigación, concuerda con el criterio de Sarabia, considerando que el término atención se refiere al proceso general de dirección del trabajo logopédico, que incluye los referentes teóricos que explican todo el proceso; sin embargo, sólo se cuenta con referentes teóricos de cómo organizar la atención logopédica de forma independiente en cada trastorno del lenguaje. Por esta razón se hace necesario, para la

ciencia logopédica, explicar cómo organizar de manera general el proceso, es decir la dirección del trabajo logopédico con énfasis en la armonía entre los sustentos logopédicos y los referentes pedagógicos.

Por su parte, Fernández G. (2005), analiza el modelo de atención logopédica en Cuba, que incluye el contexto educativo y el de salud; precisa los diferentes momentos por los que atraviesa; los sustentos teóricos y las principales categorías de esta ciencia.

Al referirse a la labor del logopeda, enfatiza en la atención logopédica y plantea que todas las acciones de la misma deben ir encaminadas a prevenir las posibles insuficiencias del desarrollo y a estimular al máximo las potencialidades de los niños.

Propuesta de ejercicios musicales para corregir la dislalia funcional.

Fundamentación.

Para la elaboración del sistema de ejercicios musicales se toma como referencia la Tesis de Maestría de Yoadnia Suárez (2020), quien propuso una "estrategia pedagógica rítmico -musical para la estimulación y desarrollo de la fluidez rítmica en niños (as) de 6to año de vida con tartamudez inicial.

El objetivo general de dicha estrategia era: Proporcionar a los especialistas de Educación Musical una herramienta de trabajo para la atención a los niños (as) con tartamudez inicial; para ello, presentó un repertorio musical con 10

canciones que favorezcan el trabajo pedagógico musical para la atención al ritmo musical, además de juegos musicales.

Otro trabajo tenido en cuenta por su relación con este estudio, es el de la Licenciada Daisy Edith Ramón Jaramillo (2020), quien en su investigación referida a la "Aplicación de ejercicios de musicoterapia para mejorar el nivel morfo-sintáctico del lenguaje en niños con dislalia funcional de 5 a 6 años", propone ejercicios de musicoterapia donde utiliza una serie de técnicas y estrategias para a través de ellas trabajar la morfosintaxis.

Entre los ejercicios de Jaramillo podemos mencionar los Movimientos corporales: estrategia opcional ya que a través de sus gestos o movimientos y mediante el lenguaje musical podemos memorizar o aprender la secuencia de diversas palabras. Juegos de palabra: con esta técnica se pretende que el niño use estructuras familiares, palabras específicas para entender contenidos extraños.

Propuesta de ejercicios musicales

Objetivo: Corregir la dislalia funcional en niños de sexto año de vida en el Círculo Infantil "Los Pinos Nuevos en Santiago de Cuba".

Universo: 7 niños (a)

Período de aplicación del experimento: Marzo a Noviembre 2022.

Ejercicio # 1 Láminas sonorizadas

Objetivo: Lograr la correcta pronunciación de los sonidos

Metodología**:** Este ejercicio se realizará mostrando a los niños/as varias láminas donde tendrán que identificar, imitar y crear sonidos sobre lo que observan. Siempre mostrándoles láminas que contengan sonidos donde exista la afectación.

Ejemplo: la lámina del gato ¿Qué es? (En 6to año de vida generalmente los niños identificarán lo que observan sin realizarle esta pregunta)

¿Cómo hace el gato? Intentarán pronunciar correctamente las vocales del "MIAU" pero también la "Fffff" de cuando este se enfada. Luego se invita cantar alguna canción que conozcan sobre el gato (según la lámina representada).

Ejercicio # 2 Juego musical

Nombre del juego: La cubanìa desde lo tradicional.

Objetivo**:** articular sonidos de canciones y cantarlas.

Metodología**:** Se invita a los niños a escuchar música tradicional cubana, (Son de la Loma, Guantanamera, El punto cubano y Mi sombrero de Yarey).

Se sientan en un círculo y se les explica que van a escoger una de las canciones que escucharon y van a cantar solo una, mientras la canten van pasando un sombrero y cuando terminen la estrofa paran de cantar y el que se quede con el sombrero responderá las siguientes preguntas

¿Qué tipo de música escuchaste?

¿Qué instrumento musical escuchaste?

¿Cómo cantarías esta canción?

Reglas del ejercicio: El niño o niña que no responda correctamente las preguntas deberá tararear una de las canciones.

Este ejercicio permite que los infantes logren articular adecuadamente los sonidos, ademàs de desarrollar su capacidad auditiva y habilidades psicolingüísticas.

Ejercicio # 3 Instrumentos musicales

Objetivo**:** Desarrollar expresión espontánea y confianza en los niños/as.

Metodología**:** Se invitará a los niños/as percutir instrumentos de percusión, para esto debe haber disponibilidad de instrumentos tales como, claves, tambor, bongos, batería, cajas de música, maracas, panderetas, cascabeles, timbal, bombo, güiro, sonajas, castañuelas, entre otros.

Estos instrumentos se entregan a los niños y ellos van a elegir el que más les guste, para que produzcan el sonido que quieran, pero siempre uno a la vez.

Tocando estos instrumentos se pretende que los niños/as desarrollen su creatividad, se expresen libremente y adquieran confianza con el musicoterapeuta. Quizá el niño, dada la afectación que presenta, no se atreva a expresarse, pero a través de la música pueda hacerlo. Puede ser un medio de comunicación muy interesante. Además, los sonidos que genere y la forma en la que actúe pueden darle al musicoterapeuta o especialista logopeda pistas sobre el estado emocional del niño.

El ejercicio puede llevarse a cabo de manera individual o grupal. Quizá se realiza de forma colectiva, el profesional puede proponer a los niños estructuras rítmicas a seguir, o diferentes patrones musicales para controlar, de este modo, la sesión.

Ejercicio # 4 Juegos de socialización

Objetivo**:** Favorecer la interacción social y reducir la timidez.

Metodología**:** Se pueden realizar coros para que los niños canten canciones sugeridas y por iniciativa propia. Siempre de manera muy motivadora, se les puede acompañar con una guitarra, con un equipo de música u otra creatividad por parte del especialista.

Este ejercicio como bien lo dice su nombre va a permitir que los niños/as interactúen, se relacionen en un ambiente armónico. Además, favorece la circulación sanguínea y la oxigenación del cerebro, con lo cual mejora la concentración y la capacidad intelectual.

Ejercicio # 5 Saludos musicales

Objetivo**:** correcta articulación de los sonidos.

Metodología**:** En este ejercicio de manera lúdica se invitará a los niños/as a realizar ejercicios de Respiración, relajación y vocalización para luego cantar una divertida canción. Destacar que desde la realización de estos ejercicios se trabajan los órganos orofaciales (huesos de la cara, laringe, mandíbula, paladar óseo, músculos de la lengua, músculos del velo del paladar, etc.) permitiendo hablar de manera adecuada.

Respiración: tomar aire por la nariz sin levantar los hombros, inflar y desinflar la barriga y no el pecho.

Relajación: hacer como el ruido del tractor, el zumbido de la abeja, el mosquito, etcétera.

Vocalización: realizar sonidos onomatopéyicos, sílabas, versos de canciones, entre otros.

Deben añadir melodía a su saludo: Buenos días, cómo estás, bien, bien, bien.

Ejercicio # 6 Estimulación de los músculos de la cara.

Objetivo**:** lograr movimientos que propicien la articulación

Metodología**:** Se pondrá una canción a medida que realizan el ejercicio en este caso sacar, la lengua, cuando se detengan debe parar. Y así se realiza cada movimiento:

Sacar la lengua y con la punta intentar tocarse la nariz, intentar tocarse la barbilla, luego intentar tocarse cada mejilla, siempre acompañado de la música para mejor concentración.

Ejercicio # 7 La vela bailarina

Objetivo**:** Instaurar el sonido (r)

Metodología**:** Para comenzar, el especialista tendrá una vela (que no presente peligro potencial y sostenida por él), el niño/a debe coger aire por la boca para apagar la vela de un solo soplido, se realizará varias veces, pero alejando cada vez más la vela, si al niño le cuesta apagar la vela podemos usar al principio absorbentes.

Luego se acompañará con música y se invita al niño/a coger aire y soplando despacio tendrá que soplar la vela para hacerla bailar, o sea, sin que se apague, al compás de la música.

Ejercicio # 8 Encestando la pelota de papel

Objetivo**:** Corregir la dislalia funcional

Metodología**:** Con fondo de música tenue, el niño/a tendrá que soplar con un absorbente las pelotas de papel hasta encestarlas en un vaso que estará sosteniendo el especialista, cuando el niño domine el ejercicio se cambiará a música rápido entonces tendrá que realizar el ejercicio más rápido, al compás de la música que escuche, se le puede decir: - Apúrate, ya casi termina la canción.

Ejercicio # 9 El aire

Objetivo**:** Corregir la dislalia funcional

Metodología**:** En este ejercicio el niño/a tendrá que, con ayuda del absorbente aspirar las pelotas y aguantando el aire para no dejarlas caer encestarla en el vaso. Siempre se estimulará cuando la realice bien, de igual manera si no lo logra se anima hasta que logre el objetivo.

Trabajamos aquí el control del aire

Ejercicio # 10 Caballito trotón

Objetivo**:** Corregir la dislalia funcional

Metodología**:** Se realiza palmeando sobre las piernas a la vez que hacemos el sonido del trote del caballo, jugando con el sonido para descubrir si el caballo es grande o pequeño o si va rápido o lento.

De igual manera se puede preguntar al niño/a

¿Cómo quieres que corra el caballo, lento o rápido?

Siempre velando que la posición de la boca y la lengua sea correcta (boca entreabierta, la punta de la lengua pegada al velo del paladar y dejarla caer con toda la fuerza posible).

Ejercicio # 11 Producción del sonido (s)

Objetivo**:** Corregir la dislalia funcional

Metodología**:** Se le dará al niño una corneta y se invitará a soplarla para escuchar el sonido que produce, de igual manera se puede pedir que imite el sonido de la corneta ¿Cómo podrías hacerlo?

Este ejercicio también se puede realizar con otro material didáctico que produzca sonidos. Ejemplo: un silbato, una trompeta.

Ejercicio # 12 Trompetillas

Objetivo**:** Corregir la dislalia funcional

Metodología**:** Se realizará con un material audiovisual donde se presentará al niño varios animales y otros medios. Un ejemplo, el caballo, se le dirá al niño/a: el caballo estornudó porque la hierba le molestó en la nariz, vamos a imitar su sonido (trompetilla) se orienta tomar mucho aire para realizar una trompetilla larga. Se preguntará ¿Qué sentiste?

Si el niño responde que sintió cosquillas es señal que surgió la vibración correspondiente, que todos sus órganos faciales estaban relajados. Se realizará varias veces.

Con cada uno de estos ejercicios se trabaja:

- Desarrollar capacidad, control y fuerza del soplo
- Estimular la movilidad y el control lingual
- Fortalecer el tono muscular de los órganos fonoarticulatorios
- Aprender a controlar la lengua para decir el fonema (r)

Ejercicio # 13 Completando frases

Objetivo**:** Corregir la dislalia funcional

Metodología**:** El especialista comenzará cantando una canción infantil conocida por los niños/as, cuando se calle el niño/a debe terminar la frase.

Siempre se buscan canciones muy familiares, que el niño domine como bien se explicaba, esto lo motiva y aporta seguridad.

Ejercicio # 14 Imitando la imagen.

Objetivo**:** Corregir la dislalia funcional

Metodología**:** Trabajamos el" yo", luego a través de tarjetas interpretar cada una de ellas, se realiza en el orden que se van mostrando sobre la mesa y así se va completando la oración. Luego realizarlo cantando enfatizando en cada una de ellas tanto su significado como su orden.

Ejercicio # 15.

Objetivo**:** Corregir la dislalia funcional.

Metodología**:** Se trabaja con cartillas personalizadas de absurdos verbales: realizamos una oración y observamos lo que no está correcto, luego la transformamos en canción e indicamos lo correcto haciendo hincapié al mencionarla para resaltar lo que no está bien.

"A mi vecino Juanito le gusta pintar, le gusta pintar, usa un gorrito y mandil hacia atrás, mandil hacia atrás, tiene muchos colores para el pintar, para el pintar, usa un palito que se llama pincel, se llama pincel".

Ejercicio # 16 El tren de palabras

Objetivo**:** Corregir la dislalia funcional

Metodología**:** Se trabaja con el juego "El tren de palabras", utilizando la canción del tren chu chu, exponemos una serie de tarjeta que contengan una secuencia y orden de una dicha información por lo general acciones y objetos. En cada vuelta de la canción se presenta una tarjeta a la siguiente otra sin que el niño olvide la anterior la nombre y diga su uso y así vaya reteniendo información y aumentando las palabras.

Ejercicio # 17 De dónde viene el sonido

Objetivo**:** Determinar la dirección del sonido y nombrar qué lo produce**.**

Materiales**:** timbre, campana, tambor, etcétera.

Metodología**:** Los niños se sientan en grupos en diferentes lugares del aula. En cada grupo habrá un juguete sonoro, se selecciona un niño al cual se le propone cerrar los ojos y adivinar de dónde viene el sonido y mostrarlo con

una mano. Si el niño señala correctamente la dirección del sonido, el maestro dice -Correcto. Entonces el niño puede abrir los ojos y debe nombrar qué juguete produce este sonido, el que hizo sonar el instrumento, se levanta y lo muestra a los demás, pasando a ocupar el lugar del niño que adivinó. Si no adivina, se le enseñará y tendrá que repetir el nombre del juguete 3 veces,

Ejemplo: Carro, carro, carro -- Mesa, mesa, mesa.

Ejercicio # 18 Quién es el más atento

Objetivo**:** Activar el vocabulario. Corregir la dislalia funcional

Metodología**:** Los niños se sientan a la mesa y el maestro o especialista les dice: -Ahora yo les pondré una canción que deben escuchar atentamente y diré los nombres de los objetos que más se repiten y escuchan en ella, por ejemplo, con el fonema (s) silla, sofá, soga, sello, etc. y ustedes deben decir qué fonema se repite en todas las palabras que yo he dicho.

El que lo sepa levanta la mano y tendrá que repetirlo escuchando la canción.

Ejercicio # 19 Marcando las sílabas

Objetivo**:** Automatizar el análisis silábico de las palabras. Corregir la dislalia funcional

Materiales**:** tambor o pandereta

Metodología**:** Los niños se sientan en fila. El maestro explica que a cada niño se le dará una Palabra la cual él debe pronunciar y tocar en el tambor tantas veces como sílabas tenga Ia palabra. Se dan palabras bisílabas, trisílabas y polisílabas, teniendo en cuenta el nivel de dificultad de cada niño; el que no se equivoque ni una vez, será el ganador.

Ejercicio # 20 Delicioso dulce

Objetivo**:** Mejorar la movilidad de la lengua y contribuir al desarrollo general del niño. Corregir la dislalia funcional

Materiales**:** equipo de música y láminas

Metodología**:** El logopeda o especialista de música invitará a los niños a celebrar un cumpleaños (sugerencia libre) y van a cantar la canción cumpleaños feliz para luego comer el delicioso dulce. Se muestra una lámina en la que aparece representado el dulce, y se le dice: - ¡Qué sabroso! Piensa que estás comiendo el dulce y te embarraste los labios y vas a saborearlo, para ello es necesario hacer los movimientos siguientes: - Elevar la lengua y realizar movimientos alrededor del labio superior.

Se le propone al niño "saborear" el dulce. Durante este juego es necesario que los niños solo movilicen la lengua. Con el objetivo de contribuir al desarrollo general del niño, el especialista puede explicar cómo se elabora el dulce, qué frutas se pueden utilizar, y sobre todo que no puede faltar, la canción de cumpleaños.

Ejercicio # 21 El caballito

Objetivo**:** Activar la punta de la lengua. Corregir la dislalia funcional

Metodología**:** Se pondrá la canción "caballito enano" Los niños se colocan en hilera, se les explicará que ellos son "los caballitos", a la señal del especialista "¡¡VAMOS!!" que será al comenzar la canción, los niños comienzan a caminar uno tras otro y chasquean la lengua, imitando la marcha de los caballos. Cuando acaba la música se detienen.

Luego se realizará individualmente para comprobar qué caballito sabe chasquear mejor.

Hay que lograr que los niños chasqueen con la punta de la lengua, por detrás de los incisivos superiores.

Ejercicio # 22 Cambiando la intensidad

Objetivo: Desarrollar la atención auditiva. Corregir la dislalia funcional la coordinación de los movimientos y la percepción diferencial de la intensidad.

Materiales**:** tambor, piano, etcétera

Metodología**:** el maestro toca el tambor, primeramente, suave, (después más fuerte, y paulatinamente va aumentando la intensidad del sonido, los niños realizan movimientos al compás de la música: cuando el sonido es suave, van caminando despacio; en la medida que aumenta la intensidad, del sonido, los niños van aumentando Ia velocidad, El que se equivoca debe situarse al final de la hilera, los más atentos serán los que queden delante.

Ejercicio # 23 El viento y los pájaros

Objetivo**:** desarrollar la discriminación de la intensidad del sonido y la coordinación de los movimientos. Corregir la dislalia funcional

Materiales**:** Equipo de música. Juguete sonoro y sillitas.

Metodología**:** El maestro divide a los niños en dos grupos: los pajaritos y el viento, se les explica que, ante el sonido fuerte de la música, soplará el viento. El grupo que hace el papel de viento debe correr libremente y en silencio por el local, los niños del otro grupo, que hacen de pajaritos, se esconden en sus nidos, cuando la música es suave, el viento se calma y los niños que hacen el papel del viento se sientan en sus puestos en silencio y los pajaritos deben salir de sus nidos y revolotear.

El primero que perciba el cambio en la intensidad del sonido y ejecute la acción recibe una banderita con la cual va a correr durante el juego; pero si este resulta poco atento se le entrega la bandera a otro niño.

Ejercicio # 24 Aves precavidas

Objetivo**:** desarrollar la respiración fisiológica. Corregir la dislalia funcional

Materiales**:** instrumentos musicales de viento: silbato, corneta, filarmónica, etcétera,

Metodología**:** El maestro les dice a los niños que los gansos son muy precavidos. Ellos tienen un jefe. Si se detienen durante la travesía a comer

o descansar, el jefe se pone a vigilar si hay algún peligro para los gansos. En caso de peligro el jefe grita y todos salen volando.

Luego invita a los alumnos a jugar a los gansos salvajes. Los niños deben elegir un jefe. A los demás se les entregan instrumentos musicales de viento y se les permite hacerlos sonar bajito. Así, tocando suavemente sus silbatos, los niños imitan los gansos, los cuales tranquilamente pican la hierba. El jefe no lo hace, él vigila por si hay peligro. De pronto el jefe da una señal (sopla fuertemente su silbato) y todos los niños corren hacia sus puestos (sillitas). Cuando se repite el juego se cambia el jefe. Es indispensable recordar que todos los niños deben tocar sus silbatos suavemente. El jefe es el único que puede tocar fuerte dos o tres veces. Este juego es mejor realizarlo al aire libre.

Ejercicio # 25 El vuelo de los pájaros

Objetivo**:** Desarrollar la respiración fisiológica, la coordinación de los movimientos y el sentido del ritmo. Corregir la dislalia funcional

Materiales**:** piano, Castañeda, tambor u otro instrumento musical.

Metodología**:** Los alumnos formarán un círculo, y acompañados por música rítmica, girarán imitando el vuelo de los pájaros con el movimiento de los brazos. La inspiración se realizará al elevar los brazos y ponerse en puntillas de pie y la espiración al volver a la posición inicial. Se dará comienzo a la

actividad con el 1ro y se terminará con el 2do. La música se extenderá para dar tiempo a realizar los movimientos hasta seis veces. (Ver Anexo 5)

Ejercicio # 26 El barco que suena mejor

Objetivo**:** desarrollar una espiración prolongada y suave; activar los músculos de los labios. Corregir la dislalia funcional

Materiales**:** frasquitos limpios, equipo de música

Metodología**:** se invitará a los niños/as escuchar la canción "Barquito de papel" y les dirá luego, miren cómo suena mi pomito cuando yo lo soplo (lo hace sonar) Sonó como un barco. Vamos a ver cómo suena el barco de Pepito, a medida que se reproduce la canción cada niño hará sonar su frasco. Se recordará que para que el pomito suene, el labio inferior debe tocar ligeramente su cuello. La corriente de aire debe ser fuerte, cada niño puede soplar varias veces.

Ejercicio # 27 La ronda de las mariposas

Objetivo**:** Desarrollar la expresividad del lenguaje y la coordinación de los movimientos. Corregir la dislalia funcional

Metodología**:** Las niñas forman un círculo de pie y cantarán la canción "Ronda de las mariposas" acompañando las palabras con un movimiento determinado.

-Yo volaba y volaba si me cansaba no lo exclamaba.

(Las niñas "aletean" suavemente con los brazos extendidos)

-Me senté a descansar. Estuve un rato sentada y de nuevo salí a volar.

(Se agachan apoyando una rodilla y las manos en el piso)

-Unas amigas me encontré y muy alegre con ellas volé.

(De nuevo "aletean" con los brazos)

-Una ronda de amigas formamos y bajo el sol alegremente nos vamos.

Ejercicio # 28 Canciones infantiles.

Objetivo**:** Desarrollo de la entonación melódica del lenguaje. Corregir la dislalia funcional

Metodología**:** Se motiva el niño a cantar la canción Niñito cubano

Gotica de lluvia ¿Para dónde vas?

voy camino al río Y después al mar.

Granito de tierra ¿A dónde tu irás?

a ver los caminos que Puedo cruzar.

Niñito cubano ¿Qué Piensas hacer?

un mundo más justo que el mundo de ayer.

Ejercicio # 29 Imitando sonidos

Objetivo**:** Desarrollar la intensidad vocal. Corregir la dislalia funcional

Materiales**:** tarjetas

Metodología**:** El especialista entregará a cada niño/a una tarjeta donde parece representado algún animal, se les explica que ellos deben imitar cómo hace este.

ANIMALES SONIDOS

Vaca ---------- Muuuuuuuuuú

Perro ---------- jau- jau- jau

Gato ---------- miau- miau- miau

Chivo ---------- beeeeeeé

Gallo ---------- Kikiri-kiiiií

Ejercicio # 30 Todos los fonemas cantados.

Objetivo**:** Corregir la dislalia funcional

Metodología**:** se invita a los niños/as a cantar la canción "Soy una taza".

<u>Soy una taza</u>

Soy una taza

Una tetera

Una cuchara

Un tenedor.

Soy un cuchillo

Un plato hondo

Un plato llano

Un cucharón

Soy un salero

Un azucarero

Una batidora

Una olla express -pi -pi

Valoración de los resultados

Una vez aplicados los ejercicios musicales en el círculo infantil en un período que comprende desde marzo hasta noviembre del 2022, los resultados demuestran un desarrollo superior con relación a los resultados iniciales, lo cual causó gran impacto en los niños en relación a sus necesidades y potencialidades lo que permitió una mejor organización y dirección de las actividades.

La propuesta de ejercicios musicales propicia el desarrollo del lenguaje en los niños, sus relaciones entre ellos les proporciona confianza seguridad emocional en los diversos contextos donde se desarrollan desde las diferentes formas organizativas del proceso educativo.

Los ejercicios musicales presentados fueron valorados por los especialistas, el 100% consideró la propuesta adecuada y plantearon como sugerencia aplicar algunos de los ejercicios en los grupos de 5to año de vida e involucrar a las familias de los niños y a la vía no institucional.

Se les presentaron los ejercicios musicales a las educadoras y maestras en los colectivos de ciclo y el 100% manifestaron su satisfacción por los mismos y las posibilidades que ofrece de atender el desarrollo del lenguaje, por la aceptación que han tenido entre los niños, plantearon tener un mayor conocimiento de este componente y su utilidad en el proceso educativo.

CONCLUSIONES

Con la realización de esta investigación se pudo alcanzar el objetivo de la misma ya que se diagnosticó el estado actual del lenguaje de los niños/as de 6to año de vida, se determinaron los fundamentos de la Musicoterapia como disciplina y técnica para la corrección de la dislalia funcional así como sus potencialidades, además de aplicar los conocimientos para dar solución al problema planteado en esta investigación mediante la elaboración de un sistema de ejercicios musicales para niños y niñas con dislalia funcional del 6to año de vida, y es gracias a su efectividad que se logra la implementación en el círculo infantil a través de la dimensión estética para ser efectuado por las especialistas, logopeda, maestras de preescolar, la especialista en educación musical así también como por familias y educadoras.

RECOMENDACIONES

Se recomienda

- Aplicar los ejercicios musicales para corregir la dislalia funcional en los niños/as de 6to año de vida del círculo infantil y otros años de vida.
- Proponer a la direcciòn del Círculo Infantil "Los Pinos Nuevos", aplicar en la práctica pedagógica la propuesta de ejercicios musicales que permita enriquecer las diferentes actividades del proceso educativo.
- Organizar acciones de preparación metodológica con el tema de la musicoterapia a logopedas, maestras de preescolar y especialistas de Educación musical.

BILIOGRAFÍA

Álvarez Navarro, H. (2019). *La musicoterapia en Educación Infantil.* Tesis de grado. Universidad de Valladolid

Artigas, José. (2008). *Cuadernos de Literatura, vol. 13, núm.25*, julio-diciembre, pp. 50-75.

Benenzon, Rolando. Omar. (1985). *Manual de Musicoterapia.* Barcelona. Paidós Ibérica S. A.

Bruscia, K, E. (2007): *Musicoterapia, métodos y prácticas*. Ciudad de México: Editorial Pax México.

Bruscia, K. E. (1987). *Improvisational Models of Music Therapy*. USA: Charles Thomas Publisher.

Bruscia, K. E. (1995): The Boundaries of Music Therapy Research, en WHEELER*, B*. (ed.): *Music Therapy Research: Quantitative and Qualitative Perspectives*. USA: Barcelona Publishers.

Cabrera, Himilce. (2008). *Programa de superación de Educación Musical para subdirectoras docentes del círculo infantil*. Tesis de Maestría en Ciencias de la Educación. Instituto Superior Pedagógico Frank País García.

Chomsky, Noam. (1977). *Lengua, lingüística y política.* Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.

Colectivo de autores (2000). *Compendio de lecturas acerca de la cultura y la Educación Estética*. Editorial Pueblo. La Habana.

Colectivo de Autores. (1999). *Programas y Orientaciones Metodológicas de la Educación Musical de 4º. Ciclo.* Editorial Pueblo y Educación.

Corona Timoteo, Claudia Alejandra. *La dislalia funcional: un trastorno del lenguaje, en la Escuela Primaria*. México, D.F: 2010.

CUBA, MINED (2014). *Programa Educación Preescolar Segunda Parte Cuarto Ciclo.* Editorial. Pueblo y Educación.

CUBA, MINED. (1999). *Educación Preescolar I parte. Programa cuarto ciclo.* Editorial Pueblo y Educación.

Dabbah, J. (1994). *Trastornos Específicos del lenguaje. Psicología Iberoamericana*. México. 1994. p. 96.

Federación Española de Asociaciones *Musicoterapia* FEAMT. (1996). *Musicoterapia.*

Félix Castañeda, Pablo. (1999). *El lenguaje verbal del niño: ¿Cómo estimular, corregir y ayudar para que aprenda a hablar bien?* p.27. Edit. UNMSN. Lima, Perú.

Fernández Pérez de Alejo, G. (2005) El área del lenguaje en los niños con necesidades educativas especiales. En María Teresa García Eligio de la Puente et al. *Psicología especial.* Editorial Félix Varela. pp.185-213.

Giráldez, Andrea. (2021). *Intervención de la musicoterapia en casos de niños con y sin diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención/ Hiperactividad (TDAH),* Universidad de Vallaloid, España

González, Reinoso. Jeaneth Patricia. (2013). *"Dislalia Funcional, en el rendimiento escolar de niños del primer año de educación general básica*". Quito. Ecuador.

Hart Dávalos, A. (1980). La educación estética como parte de la educación integral de la personalidad de los estudiantes; política del Ministerio de Cultura y su papel en relación con dicha formación. *Revista revolución y Cultura*, No. 100. Diciembre, Ciudad de la Habana.

Jaramillo, Ramón Daisy. (2017). *"Aplicación de ejercicios de musicoterapia para mejorar el nivel morfo-sintáctico del lenguaje en niños con dislalia funcional de 5 a 6 años"*. Guayaquil, Ecuador.

Jiménez, Delgado. Deysi. (2016). *Actividades de música aplicadas en la Práctica educativa*. Universidad Central de Las Villas. Santa Clara.

Jiménez, J. M. (2006). *La prevención de dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura: El método "mapal".* Madrid: Ciencias de la Educación Preescolar y Especial.

Lafarga, M. (2000*). La adquisición del lenguaje, un enfoque neurológico de la disfasia infantil, Actas de la I y II Jornadas Interdisciplinarias de Educación Especial.* Madrid, España.

MEDINA, C. T. (2016). *La MUSICOTERAPIA y el desarrollo del lenguaje.*

Merani, A. (1989). *Diccionario de Psicología.* p.97. Editorial Grijalbo, México.

Monfort, Marc. (1993). *Modelos de intervención en Logopedia*. España.

Morales Sarabia, María Elena. (2004) *Alternativa Metodológica de Intervención logopédica para potenciar el desarrollo del lenguaje oral de los alumnos con retraso mental leve del grado preparatorio.* La Habana, Cuba.

Morales, Hernández Xiomara. (2012). *Educación musical y expresión corporal*. Editorial. Pueblo y Educación.

Moreno Manso, J. M y Mateos García, M. R. (2005). *Estudio sobre la interrelación entre la dislalia y la personalidad del niño.* Electronic Journal of Research in Educational Psychology.

Muñoz del Mazo E, de la Torre Rísquez A. Musicoterapia en Pediatría. En: AEPap (ed.). *Curso de Actualización Pediatría 2016*. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2016. p. 217-24.

P.G, Richmond (1981) *"Introducción a Piaget"* (pág.139).

Palacios, Sanz, José Ignacio. (2001) *El concepto de musicoterapia a través de la historia*. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España.

Pascual, G. P. (1998) *La dislalia.* Edit. Ciencias de la educación preescolar y especial. España. pág. 27.

Pascual, García. P. (2007*). La dislalia: Naturaleza, diagnóstico y rehabilitación* (12 ed.). Madrid: Ciencias de la Educación Preescolar y Especial.

Pérez E. (2002). *Adquisición del lenguaje y componentes de la lengua*. Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de Literatura Española, Teoría de Literatura y Lingüística. Madrid: Editorial Arco Libros.

Pérez, M. (2010). *La musicoterapia. Revista Digital. Innovación y experiencias educativas.*

Piaget, J. (1968). *Los estadios del desarrollo intelectual del niño y del adolescente*. La Habana: Editorial Revolucionaria.

Real Academia Española. (s.f.). Cultura. *En Diccionario de la lengua española.* Recuperado el 10 de febrero de 2019, de https://dle.rae.es/cultura?m=form

Rello, L. (2014). *Superar la dislexia, una experiencia personal a través de la investigación*. (E. Paidós, Ed.) Editorial. Colección Educación.

Rigau, Gemma. (2008). *¿Por qué la lingüística necesita una teoría del lenguaje?* Revista de Catalunya. Núm. 34. Barcelona. España.

Rivero, Cuca (1996). *Cantemos y juguemos en el Círculo Infantil*. Editorial Pueblo y Educación.

Rodríguez, M. N. (2017). *Actividades Teatrales para enriquecer la expresión oral en escolares de primer grado de la escuela rural Crescencio Valdés.* Universidad Central de Las Villas. Santa Clara.

Sánchez, Escobedo Pedro*. Compendio de educación especial.* Edit. Manual moderno. México. 1977.

Sánchez, Ortega. Paula. (2012) *Educación musical y expresión corporal*.. Editorial. Pueblo y Educación.

Sapir, Edward. (1995). *El lenguaje: introducción al estudio del habla.* Ed. Fondo de Cultura Económica.

Suárez Suárez, Y. (2020). *La atención logopédica a niños (as) preescolares con tartamudez inicial*. Tesis de maestría. Universidad de Oriente.

Taboada, María Beatriz. (2011). *Análisis crítico del discurso Sociolingüística*. Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

Tejedor, Cinthia. (2016). *La musicoterapia y el desarrollo del lenguaje*.

Thayer Gaston y Benenzon, R. O. (1992). *Teoría de la Musicoterapia.* Madrid: Mandala Ediciones.

Thayer Gaston, E y otros. (1982). *Tratado de Musicoterapia.* Barcelona: Paidós

Anexo # 1

Guía de observación para la Actividad Programada.

Objetivo: Corroborar el desarrollo que presentan los niños y niñas del cuarto año de vida en el desarrollo del lenguaje.

Indicadores

- Creación de las condiciones para ejecutar la actividad.
- Valorar las características y cualidades del material que se utiliza.
- Habilidad de los niños al realizar la audición.
- Habilidad de escuchar con un tema seleccionado.
- Utilización de los diferentes géneros cubanos en la audición.
- Tratamiento individualizado según las características del desarrollo de los niños.

Anexo # 2

Entrevista a la logopeda

Objetivo: Conocer el nivel de preparación que poseen los maestros logopedas sobre la dislalia funcional y qué métodos utilizan para corregir este trastorno.

Interrogantes:

1. ¿Qué conoces sobre la dislalia funcional?
2. ¿Cuáles son las mayores dificultades que presentan los niños con dislalia funcional?
3. ¿Conoce usted la musicoterapia?
4. ¿Ha utilizado la música como método de trabajo para corregir la dislalia funcional?
5. ¿Qué actividades y métodos realizas para corregir la dislalia funcional en niños/as preescolares? Mencione algunas de ellas.

Anexo # 3

Entrevista a las maestras de preescolar

Objetivo: Conocer el nivel de preparación que poseen los maestros sobre el conocimiento de la dislalia funcional

Interrogantes:

1. ¿Conocen ustedes qué es la dislalia funcional?
2. ¿Cuáles son las mayores dificultades que presentan los niños en el lenguaje?
3. ¿Conocen ustedes la musicoterapia?
4. ¿Han utilizado la música como método de trabajo para corregir la dislalia funcional?
5. ¿Qué actividades y métodos realizan para trabajar con los niños que presentan dislalia funcional? Mencione algunas de ellas.

Anexo # 4

Entrevista a la especialista de Educación musical

Objetivo: Conocer el nivel de preparación que posee la especialista de educación musical sobre la dislalia funcional y qué métodos utiliza para corregir este trastorno.

Interrogantes:

1. ¿Conoce usted el trastorno conocido como dislalia funcional?
2. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que han presentado los niños con dislalia funcional?
3. ¿Conoce usted la musicoterapia?
4. ¿Cómo has utilizado la música como método de trabajo para corregir la dislalia funcional?
5. ¿Qué actividades y/o ejercicios realizas para corregir la dislalia funcional en niños/as preescolares? Ejemplifique alguno de ellos.

Anexo # 5

